

성인 Daily Day 07 - 비만주사 기본

비만 클리닉

GLP-1/GIP

KCD E66.x

작성일 2026-07-05

오늘의 목표

위고비, 삭센다, 마운자로 등 비만 주사 상담에서 적응증, 금기, 시작 전 검사, 부작용 설명, 유지 용량 후 중단 기준을 정한다. 제품명과 적응증은 국내 허가사항을 매번 확인한다.

1. 첫 3분 Triage

중단/의뢰 신호: 심한 지속 상복부 통증 또는 등으로 뻗는 통증, 반복 구토, 우상복부 통증/황달/발열, 탈수와 소변 감소, 임신, serious hypersensitivity.

- BMI, 허리둘레, 당뇨/고혈압/지질/지방간/수면무호흡 동반 여부를 확인한다.
- 임신 가능성, 수유, MTC/MEN2, pancreatitis, 담낭질환, severe GI disease 병력을 묻는다.
- insulin/sulfonylurea 병용 여부와 저혈당 위험을 확인한다.
- 비용, 장기치료, 중단 시 체중 재증가 가능성을 설명한다.

2. 핵심 문진/PE

문진 5개	Physical exam
BMI/체중 변화, 대사질환, 임신/수유, 췌장염/담석/위마비, MTC/MEN2/약물 알레르기	체중, BMI, 허리둘레, BP/HR, 복부 압통/RUQ 압통, 갑상선/경부, 근감소 위험

3. 검사

상황	검사	해석/행동
시작 전	HbA1c/FBS, lipid, AST/ALT, Cr/eGFR	대사위험 기준값, 당뇨 약 조정.
임신 가능성	hCG	임신 중 비만 약물치료는 피한다.
복통/구토	lipase/amylase, LFT, 영상 고려	췌장염/담낭질환 의심 시 중단/의뢰.
추적	체중, 허리둘레, BP, GI 부작용	증량 가능성과 효과 판정.

4. 약제별 Regimen

약제	시작/증량	주의
Liraglutide	0.6 mg sc qd 시작, 주 단위 증량	매일 주사, GI 부작용/담낭/임신 주의.
Semaglutide	0.25 mg sc weekly 시작, 보통 4주 간격 증량	오심/구토, 담낭질환, pancreatitis 경고.
Tirzepatide	2.5 mg sc weekly 시작, 4주 이상 간격 증량	국내 적응증 확인, GI/담낭/췌장 위험.

금기/주의: MTC/MEN2, serious hypersensitivity, 임신/수유, pancreatitis 병력, severe gastroparesis, active gallbladder disease, insulin/SU 병용 저혈당 위험.

5. KCD / 중단 기준

E66.x	비만. BMI와 동반질환, 상담 내용 기록.
R63.5	비정상 체중 증가 평가 단계.
E11.x/I10/E78.x/K76.0	당뇨, 고혈압, 이상지질혈증, 지방간 동반 시.

- 유지 용량 도달 후 3개월 안에 체중 5% 이상 감량이 없으면 중단/변경 검토.
- 심한 GI 부작용, 탈수, 체장염/담낭염 의심, 임신, hypersensitivity면 즉시 중단.
- 감량 중 근손실 예방을 위해 단백질과 저항운동 계획을 같이 세운다.

6. 환자 설명 스크립트

비만 주사는 식욕을 줄이고 포만감을 오래가게 해서 생활요법을 지속하기 쉽게 만드는 치료입니다.

심한 복통이 등으로 뻐거나 계속 토하고 물도 못 마시면 약을 더 맞지 말고 바로 연락해야 합니다.

체중이 빠질 때 근육도 줄 수 있어 단백질 섭취와 근력운동을 같이 해야 결과가 오래 갑니다.

7. 자가체크

- GLP-1/GIP 비만주사 시작 전 확인할 암 가족력은?
- 체장염 의심 증상은 어떻게 설명하나?
- insulin/SU 병용 환자에서 추가로 볼 위험은?
- 유지 용량 후 3개월 효과 판정 기준은?
- 근손실 예방 상담 문장은?

참고 출처

KSSO 2024 Obesity Guideline: <https://www.jomes.org/journal/view.html?doi=10.7570/jomes25042>
FDA Wegovy/Saxenda/Zepbound/Mounjaro labels, 2026.